SDD 283 Sujet n°1

Spécialité : Pneumologie

Date : 23/10/2024
Auteures : Maïla Moulin (DES médecine générale, EN 2024), Clémentine Vue (DES MIR, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2024)

Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage principal	Iconographie
Item(s) en lien avec la station	Item 188 - Asthme, rhinite
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 283 - Consultation de suivi d'un patient asthmatique
Matériel nécessaire à la station	Une table, deux chaises, une feuille d'interprétation d'EFR
Contexte de la station	Consultation de suivi chez le médecin généraliste

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste remplaçant et vous recevez pour la première fois M. L, 23 ans.
Il a pour seul antécédent un asthme apparu dans l'enfance. Ses traitements habituels consistent en la prise de salbutamol si besoin.
Il n'a plus fait aucun bilan pour son asthme depuis ses 16 ans.

Vous le recevez ce jour en consultation car il ressent une dyspnée à l'effort. Il vous apporte un examen complémentaire réalisé une semaine avant la consultation, qu'il vous a posé sur votre bureau.
Il est en bon état général par ailleurs, ses paramètres vitaux sont normaux.

Consignes :
Au cours de cette station, vous devez :

- Interroger le patient sur l'équilibre de son asthme
- Interpréter l'examen complémentaire
- Conclure et énoncer la prise en charge au patient

Vous ne devez pas :

- Réaliser d'examen physique

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
1.	Demande le **nombre de crises sur les 4 dernières semaines**.	1 pt
2.	Interroge sur la **fréquence de consommation de ventoline**.	1 pt
3.	Interroge sur la **prise de corticoïdes systémiques** à la suite d'exacerbations sur l'année passée.	1 pt
4.	Evalue la **gêne au quotidien** *(ex : réveils nocturnes, limitation de l'activité physique, dyspnée, toux chronique…)*	1 pt
5.	Demande si le patient est déjà passé aux **urgences/a déjà été hospitalisé pour son asthme**.	1 pt
6.	Demande le **ressenti** du patient sur le contrôle de son asthme.	1 pt
7.	Identifie des **explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)**.	1 pt
8.	Évoque un trouble ventilatoire **obstructif** car **Tiffeneau** (ou VEMS/CVF) **< 0.7**	1 pt
9.	Evoque le caractère **réversible** de l'obstruction car, après prise de bronchodilatateurs : - le VEMS augmente de 12% - ET le VEMS augmente de 200 mL (*les deux critères sont attendus pour avoir le point*)	1 pt
10.	Affirme **l'absence de syndrome restrictif** car la capacité pulmonaire totale **(ou CPT) > 80%**.	1 pt
11.	Affirme **l'absence de distension thoracique** car : - la **capacité pulmonaire totale (CPT) < 120%** - OU le **rapport VR/CPT < 30%** *(l'un des deux critères est attendu pour avoir le point)*	1 pt
12.	Affirme **l'absence de trouble de la diffusion** car la **DLCO > 70%**	1 pt
13.	Conclue à un **asthme non équilibré** nécessitant l'introduction **d'un traitement de fond** *(les deux éléments sont attendus pour avoir le point)*.	1 pt
Communications et attitudes		

1.

APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

2.

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL	**15 points**

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le patient consulte un médecin généraliste remplaçant pour un bilan de son asthme.

Plan de la station ECOS :

Le patient est positionné en face du médecin généraliste. Devant lui sur sa table, une feuille sur laquelle apparaît l'iconographie (explorations fonctionnelles respiratoires).

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Bonjour docteur, je viens vous voir pour un bilan de mon asthme parce que je reprends le sport depuis peu et je ne me sens pas très à l'aise. Je suis venu avec un examen que j'ai réalisé il y a une semaine"

Identité du patient :

M. L. 23 ans

Mode de vie :

Pas d'intoxication alcoolo-tabagique Vous essayez de reprendre petit à petit le sport avec des footings le matin autour de chez vous, 2-3 fois par semaine environ 30 minutes

Comportement global :

Inquiet car vous êtes de plus en plus gênés.

Antécédents personnels :

- Asthme depuis ses 6 ans
- Allergies aux arachides

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

SALBUTAMOL pris si besoin (cf. symptômes positifs)

Motif de venue :

Vous vous sentez gênés au cours de vos séances de sport (footings).
Vous avez consulté votre médecin généraliste habituel il y a 2 semaines qui vous a prescrit un examen complémentaire. Vous avez réalisé cet examen il y a 1 semaine (vous n'avez aucune idée de quoi il s'agit) que vous avez rapporté ce jour.

Symptômes positifs :

- Asthmatique depuis 4-5 ans

- Depuis 4-5 mois, davantage de crises nécessitant de la ventoline à chaque fois (alors que pas de besoin ces dernières années)

- 6 crises le mois dernier, chaque fois lors de vos footings, avec prise de salbutamol ayant permis de calmer la crise

- A réalisé une session d'éducation thérapeutique pour apprendre à bien prendre sa ventoline

- Asthénie en raison d'une toux nocturne insomniante

- 0 passage aux urgences ni hospitalisation

- Vous sentez que votre asthme "revient", et qu'il pourrait être mieux équilibré en ce moment

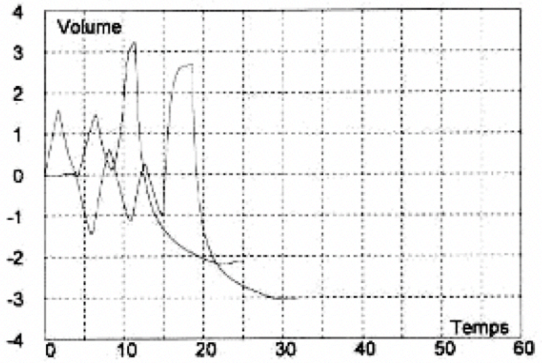
Questions de relance :

- Si l'étudiant n'a pas abordé la prise en charge après l'interprétation des examens : "qu'est-ce que je dois faire maintenant docteur ?"

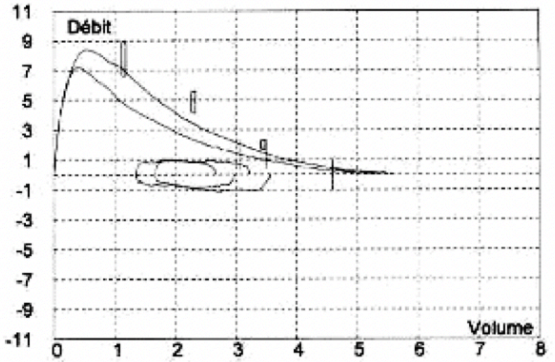
Iconographie

	Meilleur Test avant BD			Meilleur Test après BD			
	Norme	Mes.	%Norme	Mes.	%Norme	Dif. Pré	Dif. Pré%
CV(L)	4,79	5,42	113	5,73	118	0,31	6
VT(L)	----	1,49	----	1,36	----	-0,13	-9
VRI(L)	----	1,78	----	2,46	----	0,68	38
VRE(L)	----	2,15	----	1,92	----	-0,24	-11
CI(L)	----	3,27	----	3,82	----	0,55	17
CPT (L)	----	5,89	114	----	----	----	----
VR/CPT (%)	----	22	----	----	----	----	----
VEMs/CVF(%)	79	58	73	63	80	5	9
VEMs/CV(%)	79	56	72	61	78	5	8
CVF(L)	4,60	5,30	115	5,57	121	0,27	5
VEMs(L)	3,72	3,05	82	3,50	94	0,44	14
DEP(L/S)	8,94	7,25	81	8,40	94	1,15	16
D75(L/S)	7,79	4,28	55	5,90	76	1,63	38
D50(L/S)	4,86	1,89	39	2,49	51	0,60	32
D25(L/S)	2,02	0,59	29	0,70	35	0,11	18
DEM(L/S)	4,05	1,52	37	1,91	47	0,39	26

Courbe volume temps



Courbe débit volume



Capacité de diffusion du monoxyde de carbone CO:

	Norme	Test 1 Mes.	%Norme	Test 2 Mes.	%Norme	Moyenne Mes.
Hb(gr/100ml)	14,60	14,60		14,60		14,60
CRF'sb(L)	----	----	----	----	----	----
VI(L)	----	----	----	----	----	----
VA(L)	----	----	----	----	----	----
KCO cor(mL/mmHg/Mi)	4,34	3,56	82	3,54	81	3,55
DLCO cor(mL/mmHg/M	31,01	23,07	74	21,59	78	22,33